



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : حنان محمد صقر عبدالظاهر

العنوان : برنشت

المحافظة : الجيزة

رقم البطاقة : 27904162100341 رقم التليفون : 01141474637 تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 16-04-1979 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: حنان محمد صقر عبدالظاهر National ID: 27904162100341	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



حنان
محمد صقر عبدالظاهر
قرية برنشت
مركز الصف - الجيزة



٢٧٩٠٤١٦٢١٠٠٣٤١

LH6987532

Name: <u>حنان محمد صقر عبدالطاهر</u>		
MR. : <u>6062</u>		
Detailed Medical Report		
		السيد
تجبة طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 46-year-old individual with triple-negative breast cancer (TNBC) undergoing neoadjuvant therapy (NACTH) with a planned sequence of four cycles of TC followed by four cycles of pembrolizumab, then adjuvant chemotherapy (AC) plus pembrolizumab for four cycles. On 25 January 2026 the patient was scheduled for week 9 of TC (which was not received on 18 January 2026 due to pending approvals) and subsequently weeks 10 and 11 were arranged through the pharmacy. The patient has therefore completed weeks 9, 10, and 11 of the TC regimen. On 1 February 2026 the pharmacy visit documented administration of week 10 taxol 150 mg and carboplatin 250 mg. The patient has therefore completed week 10 of taxol + carboplatin. On 8 February 2026 the pharmacy record indicated week 11 taxol 150 mg plus carboplatin AUC 2 with a CBC accepted. The patient has therefore completed week 11 of taxol + carboplatin. On 15 February 2026 the oncology note recorded that the patient, weight 91 kg, height 165 cm, with a performance status of 2, has right-sided breast cancer staged cT4b N2 M0, triple-negative, Ki-67 50-60 %. Physical examination showed a right breast mass measuring 5 × 6 cm and a regressive right axillary lymph node 2 × 2 cm. For week 12 the patient received neoadjuvant taxol 150 mg and carboplatin AUC 2. The patient has therefore completed week 12 of taxol + carboplatin. On 1 March 2026 the oncology assessment noted a right lower quadrant mass 5 × 6 cm and right axillary lymph node 3 × 3 cm. The patient proceeded to cycle 1 (C1) of AC neoadjuvant therapy with Adriamycin 120 mg/m² and cyclophosphamide (Endoxan) 1200 mg. The patient has therefore completed cycle 1 of AC. On 15 March 2026 the internal medicine note reported that cycle 2 (C2) of AC neoadjuvant therapy with Adriamycin 120 mg/m² and cyclophosphamide 1200 mg was originally planned as dose-dense (DD) AC but was delayed because of insufficient G-CSF availability. The patient attended two weeks after C1 and the C2 dose was postponed to the following week due to neutropenia. The patient has therefore completed cycle 1 of AC and is pending cycle 2. On 22 March 2026 the patient received cycle 2 (C2) of AC neoadjuvant therapy with Adriamycin 120 mg/m² and cyclophosphamide 1200 mg. Laboratory results showed hemoglobin 9.3 g/dL, total leukocyte count (TLC) 5 × 10⁹/L, and platelets 430 × 10⁹/L. The patient has therefore completed cycle 2 of AC. On 12 April 2026 the patient received cycle 3 (C3) of AC neoadjuvant therapy with Adriamycin 120 mg/m² and cyclophosphamide 1200 mg. Labs performed externally were acceptable: TLC 6.4 × 10⁹/L, hemoglobin 9.6 g/dL, platelets 306 × 10⁹/L, with normal liver and kidney function tests. The		
تحريراً في ,		
	الوقت :	19-09-2026 التاريخ :
	dina makram	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

patient has therefore completed cycle 3 of AC.

On 3 May 2026 the patient received cycle 4 (C4) of AC neoadjuvant therapy with Adriamycin 120 mg/m² and cyclophosphamide 1200 mg; external laboratory results were accepted. The patient has therefore completed cycle 4 of AC.

On 11 August 2026 the patient, still a 46-year-old with weight 91 kg and height 165 cm, performance status 2, presented two weeks post-right modified radical mastectomy (MRM) with right-side weakness. Pathology of the surgical specimen showed invasive ductal carcinoma, grade 3, staged ypT2 ypN2, with residual cancer burden (RCB) class III. Brain MRI revealed left frontal and left temporal intra-axial lesions suggestive of metastases; neurosurgery was consulted for possible resection, with stereotactic radiosurgery (SRS) as an alternative if unresectable. The plan was to initiate first-line capecitabine. The patient is now being evaluated for metastatic disease and planned for capecitabine therapy.

On 23 August 2026 the oncology note indicated that radiotherapy is pending following cycle 1 of capecitabine (Xeloda) administered as 4 g in the morning and 3 g in the evening for 14 days. The patient currently has a chest infection, ongoing brain metastases (left frontal and left temporal lesions), tiny pulmonary nodules, and multiple sclerotic osseous foci, but is otherwise free of significant symptoms. The current plan is to treat the chest infection, proceed with radiotherapy when feasible, and continue capecitabine as scheduled.



٢٠٢٥/٠٨ ٢٧٩.٤١٦٢١.٠٠٣٤١
رربة منزل



انثى
مطلقة
مطلقة
عادل عبدانفي عبدالله علي
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/٠٨/١٨



Patient's Name: Hanan Mohammed Saqr
Date: 2026-06-04
Referred by: Prof. Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt



**BILATERAL DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY WITH HIGH
RESOLUTION BREAST SONOGRAPHY REVEALED**

CLINICAL SUMMARY:

A known case of right breast carcinoma, treated with NACT, for follow up

FINDINGS:

RIGHT BREAST:

- Fairly dense, (ACR B).
- The UOQ is still the seat of an irregular highly dense mass, associated with slight skin thickening and faint pleomorphic calcifications.
- Complimentary U/S demonstrated the underlying hypoechoic mass located at 9-10 o'clock, measuring about 9.5x5cm, laying right beneath the skin and reaching the nipple.
- Pathological level I axillary nodes are seen, with reaching 6.5x4cm exhibiting extra capsular involvement.
- No infra or supra-clavicular pathological lymph node seen.

LEFT BREAST:

- Fairly dense, (ACR B).
- No mass, spiculation or suspicious micro calcifications.
- Complimentary U/S examination depicted anechoic dilated ducts reaching 3.8mm.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- A level I axillary node is seen with cortical thickness reaching 6mm, ? pathological

CONCLUSION:

Right breast (BIRADS 6): Rather stationary course of the locally advanced malignant process as described

Left breast (BIRADS 4a): Simple duct ectasia with an indeterminate axillary node

Best regards,
Dr. Mahi Mokhtar